

COMPRESSÃO MEDULAR — CORTICOIDE + RM + TRATAR JÁ

EMERGÊNCIA ONCOLÓGICA — TEMPO É FUNÇÃO NEUROLÓGICA

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO PRECOSES PRESERVAM A MARCHA

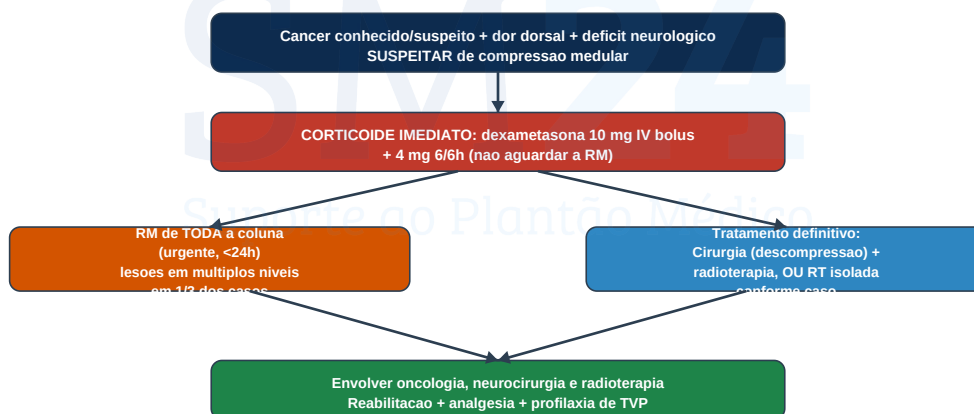
- O status neurológico ANTES do tratamento é o principal preditor do desfecho funcional
- Paciente que chega deambulando tem chance muito maior de continuar andando se tratado a tempo
- Paciente já paraplégico raramente recupera a marcha — não esperar para confirmar
- Corticoide deve ser iniciado IMEDIATAMENTE à suspeita (antes mesmo da RM)
- RM de toda a coluna é o exame de escolha (lesões em múltiplos níveis em 1/3 dos casos)
- Atraso de horas pode significar paraplegia permanente e perda de controle esfincteriano

ETIOLOGIA E APRESENTAÇÃO

Aspecto	Detalhe
Tumores mais comuns	Mama, pulmão, próstata (metástases vertebrais); mieloma, linfoma
Nível mais afetado	Torácico (60%), lombossacro (30%), cervical (10%)
Mecanismo	Metástase no corpo vertebral → invasão epidural → compressão da medula/cauda equina
1o sintoma (precoce)	DOR nas costas (>90%) — piora ao deitar, progressiva, semanas antes do déficit
Sinais tardios	Fraqueza de membros, nível sensitivo, retenção/incontinência urinária e fecal
Síndrome da cauda equina	Anestesia em sela, disfunção esfincteriana, fraqueza distal assimétrica

ABORDAGEM DA COMPRESSÃO MEDULAR

COMPRESSÃO MEDULAR — CORTICOIDE + RM + TRATAR



TRATAMENTO DEFINITIVO — CIRURGIA vs RADIOTERAPIA

Modalidade	Indicação	Observação
Cirurgia descompressiva + RT	Compressão por osso/instabilidade, déficit recente, tumor radiorresistente, dúvida diagnóstica	Melhor preservação da marcha (estudo Patchell) em candidatos
Radioterapia isolada	Tumor radiosensível (linfoma, mieloma, mama, próstata), múltiplos níveis, mau status cirúrgico	Mais utilizada; alívio da dor e controle local
Quimioterapia	Tumores quimiossensíveis (linfoma, germinativos, mieloma)	Adjuvante; pode ser primária em casos selecionados
Vertebroplastia / cimento	Dor por fratura vertebral patológica sem compressão neural	Alívio da dor; não trata compressão

CORTICOIDE E SUPORTE

Dexametasona

- Iniciar **IMEDIATAMENTE** à suspeita (não aguardar a RM)
- Esquema comum: 10 mg IV em bolus + 4 mg IV/VO de 6/6h
- Reduz edema vasogênico medular e a dor
- Desmame gradual após o tratamento definitivo (RT/cirurgia)
- Vigiar: hiperglicemia, úlcera (profilaxia gástrica), psicose, infecção
- Em linfoma: pode mascarar/tratar o tumor — colher diagnóstico antes se possível

Suporte e Reabilitação

- Analgesia multimodal: opioides + adjuvantes (dor neuropática)
- Profilaxia de TVP (paciente imobilizado + neoplasia)
- Sondagem vesical se retenção urinária
- Cuidados com pele (prevenção de úlcera de pressão)
- Fisioterapia e reabilitação precoces
- Abordagem multidisciplinar: oncologia, neurocirurgia, RT, cuidados paliativos

PONTOS-CHAVE NO PS

NÃO ATRASAR

- ☐ Dor dorsal progressiva em paciente com câncer = compressão medular até prova em contrário
- ☐ Corticoide (dexametasona) **IMEDIATO** à suspeita, antes da confirmação por imagem
- ☐ RM de TODA a coluna é o exame de escolha (urgente)
- ☐ O status neurológico pré-tratamento é o principal preditor de recuperação funcional
- ☐ Acionar neurocirurgia + radioterapia + oncologia precocemente
- ☐ Cirurgia + RT preserva melhor a marcha em candidatos selecionados (déficit recente, instabilidade)

Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Paciente com câncer de mama metastático apresenta dor dorsal progressiva há 2 semanas e, hoje, fraqueza nas pernas e dificuldade para urinar. Qual é a conduta IMEDIATA?

- A) Aguardar a RM antes de iniciar qualquer tratamento
- B) Iniciar dexametasona imediatamente + solicitar RM de toda a coluna em caráter de urgência
- C) Analgésico e reavaliação ambulatorial em 48h
- D) Tomografia de crânio
- E) Iniciar quimioterapia paliativa apenas

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é o exame de escolha para o diagnóstico da compressão medular neoplásica?

- A) Radiografia simples de coluna
- B) Tomografia de coluna sem contraste
- C) RM de toda a coluna
- D) Cintilografia óssea
- E) Mielografia convencional

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Qual é o principal fator preditor do desfecho funcional (marcha) na compressão medular neoplásica?

- A) O tipo histológico do tumor
- B) O status neurológico do paciente ANTES do início do tratamento
- C) A idade do paciente
- D) O nível da coluna acometido
- E) O valor do CA 15-3

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

Qual é o sintoma MAIS PRECOCE e frequente da compressão medular neoplásica?

- A) Incontinência urinária
- B) Paraplegia
- C) Dor nas costas (dorsal), progressiva, que piora ao deitar
- D) Anestesia em sela
- E) Febre

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Em qual situação a cirurgia descompressiva (seguida de radioterapia) é preferível à radioterapia isolada?

- A) Tumor radiosensível em múltiplos níveis
- B) Paciente paraplégico há mais de 48h
- C) Compressão por fragmento ósseo/instabilidade vertebral, déficit neurológico recente ou tumor radorresistente, em paciente com bom status
- D) Mau estado geral e expectativa de vida muito curta
- E) Linfoma com compressão difusa

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Compressão medular neoplásica é emergência oncológica. Conduta imediata: dexametasona (10 mg IV bolus + 4 mg 6/6h) ANTES da confirmação por imagem + RM de toda a coluna em urgência. O atraso pode causar paraplegia e perda esfinteriana permanentes.

QUESTÃO 2 → Resposta: C

RM de TODA a coluna é o exame de escolha — detecta a compressão epidural, o nível e múltiplas lesões (presentes em ~1/3 dos casos). A radiografia e a TC têm sensibilidade inferior. A mielografia foi substituída pela RM. Não atrasar o corticoide aguardando a RM.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

O status neurológico ANTES do tratamento é o principal preditor do desfecho funcional. Pacientes que ainda deambulam têm grande chance de continuar andando se tratados rapidamente; pacientes já paraplégicos raramente recuperam a marcha. Por isso o reconhecimento e tratamento precoces são cruciais.

QUESTÃO 4 → Resposta: C

A dor dorsal (nas costas) é o sintoma mais precoce e frequente (>90%), surgindo semanas antes do déficit neurológico. Caracteristicamente progressiva e pior ao deitar (vs dor mecânica que melhora). Reconhecê-la em paciente oncológico permite o diagnóstico antes do déficit motor.

QUESTÃO 5 → Resposta: C

Cirurgia descompressiva + RT (estudo Patchell) é preferível quando há compressão por fragmento ósseo/instabilidade vertebral, déficit neurológico recente, tumor radorresistente ou necessidade de diagnóstico histológico, em paciente com bom status e expectativa de vida razoável. RT isolada para tumores radiosensíveis, múltiplos níveis ou mau status.

SM24
Suporte ao Plantão Médico